

Un adulto autistico più anziano che sostenete a casa

Per assistenti domiciliari, assistenti personali e personale di supporto di comunità — sostenere un adulto autistico più anziano (circa 60+).

L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione di un adulto più anziano si è sempre chiusa in pochi „tunnel” profondi e intensi. Molti adulti autistici più anziani non sono mai stati individuati e portano una vita di masking e di bisogni non soddisfatti. Le vostre visite possono essere la relazione più prevedibile e accogliente della loro settimana. Proteggete le routine, gli interessi e gli oggetti lifelong; riducete il carico sensoriale; comunicate alla lettera; e state attenti al burnout e al dolore che il „non lamentarsi” può nascondere.

Cosa potreste vedere — e cosa sta davvero accadendo

Potreste vedere...	Cosa spesso sta accadendo
Stessa routine, oggetti, interessi — ogni visita	Prevedibilità e flusso sono regolazione e identità
Evita le cure, annulla, „non gli piace che veniate”	Esperienze negative lifelong + barriere sensoriali/comunicative
Risposte lente, inusuali; sembra confuso	Spesso tempo di elaborazione + differenza autistica — non necessariamente demenza
Non segnala dolore o sintomi	Differenze di interocezione ; „non si lamenta” ≠ „non soffre”
Ritirato, esausto	Forse decenni di burnout accumulato

Provate questo

- **Siate la presenza prevedibile e accogliente** — stessa persona, stesso orario, stesso piano; avvisate prima di ogni cambio.
- **Protegete routine, interessi e oggetti lifelong** — rimuoverli „per la sicurezza” può causare un danno reale.
- **Comunicare in modo chiaro, letterale e lento**, per iscritto dove aiuta; concedete ampio tempo di elaborazione.
- **Riducete il carico sensoriale** e tenete conto dei cali di udito/vista che si sommano alle differenze lifelong.
- **Chiedete proattivamente di dolore e sintomi** — non aspettate che li menzionino.

Da evitare

- Disruptare le routine o rimuovere oggetti familiari.
- Dare per scontato che lentezza o uno stile diverso significhino declino cognitivo — valutate, non presupponete.
- Equiparare il silenzio o una presentazione „sistemata” all'essere „bene”.

Quando chiedere altro supporto

State attenti al **burnout autistico** (spesso decenni nella sua formazione) e all'**isolamento sociale** (un rischio maggiore). Il dubbio **demenza-o-differenza?** è difficile e poco studiato — segnalate i cambiamenti con tatto e cercate una valutazione informata sull'autismo invece di presupporre. Segnalate ogni nuovo malessere come una possibile red flag medica.

Se la persona è una donna

Le donne autistiche più anziane sono un gruppo particolarmente sotto-individuato, avendo mascherato per una vita; una storia di „ansia” o burnout accanto a una differenza lifelong merita seria considerazione dell'autismo.

Informazioni su questa guida

Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — la guida per la **famiglia** (Parte 5), la guida **Pratici e sanità lungo l'arco di vita** (Parte 3.5) e la sintesi sul **Monotropismo**. Usa il linguaggio con l'identità per prima. **Informativa — non è strumento diagnostico**. Le evidenze sull'età avanzata sono scarse; adattatela alla singola persona.

Fonti chiave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Klein et al. (2024, invecchiamento e autismo); Raymaker et al. (2020); Kelly Mahler (2024); OAR (invecchiamento nello spettro). Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.